

Información Paciente

Nombre : Alicia Paola Guzman Hernandez

Rut : 11.530.009-1

N° Archivo : A642929

N° Epicrisis

415644

Edad : 54a 9m 3d

Fecha Nacto: 31/12/1969

Sexo : Femenino

Dirección : Psj. La Gargola 2116 Villa Peñon 2 De Ma

Comuna : Puente Alto

Teléfono : 9 8714 1930

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Intermedio Quirúrgico

Fecha Ingreso : 25/09/2024 07:15

Días Estadía: 8

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 03/10/2024 10:10

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Adenocarcinoma de ampolla de Vater

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiologia

Resumen Clínico

ANTECEDENTES:

Alergias: Cefadroxilo

Médicos: Hipotiroidismo, Asma Bronquial, Fibromialgias, Artrosis de rodilla, RGE, hernia hiatal, Lumbalgia, Hernia discal.

Quirúrgicos

Cesáreas, (4), túnel carpiano, dedo en gatillo.

ANAMNESIS:

Paciente de 54 años con antecedentes de trastorno del ánimo, fibromialgia y obesidad. En contexto de alteración de pruebas hepáticas y dilatación de vía biliar se realiza diagnóstico de adenocarcinoma de ampolla de Vater (biopsia endoscópica). Sin enfermedad a distancia en TAC TAP de etapificación.

Prevía prehabilitación kinésica, evaluación cardiológica y apoyo nutricional se decide cirugía de Whipple con intención curativa.

Ingresa electivamente al hospital Dr. Sótero del Río para pancreatoduodenectomía abierta que se realiza sin incidentes el 25/09/2024, evidenciándose masa tumoral a nivel de la ampolla de Vater, con compromiso de la vía biliar distal.

Evoluciona con fístula pancreática bien conducida por drenajes, presentando sin embargo el día 5 postoperatorio hemorragia intraabdominal exteriorizada por los drenajes, por lo cual debe ser reintervenida de urgencia el 30/09/2024 realizándose laparotomía exploradora, aseo y pancreatectomía total + esplenectomía dado hematoma en relación a pancreatoyeyuno anastomosis y sangrado desde vena esplénica Inflamatoria desgarrada en contexto inflamatorio de fístula pancreática.

Cursa con shock hemorrágico siendo politransfundida en pabellón y con requerimientos altos de DVA.

Se traslada a UCI quirúrgica el 01/10/24.

Ingresa a UCI SAS 1 tibia perfundida con reactividad pupilar 3 DVA.

Pupilas 4 mm normorreactivas a la luz y acomodación

Rscs rítmicos sin soplos

Rsrscs roncus escasos sin hipoventilaciones

Abdomen blando depresible con apósitos en herida quirúrgica, Jp der y tubular izq.

Ext móviles sin edemas uso de mae, pulsos simétricos positivos

Neuro SAS 1

Piel Tibio bien perfundido llen capilar 3sg.

MICROBIOLOGÍA:

Fecha Epicrisis : 10/10/2024 17:23

Fecha Última Actualización: 10-10-2024 17:23:11

Página 2 de 3

01/10: Vih (-)

30/09: CC Liq Peritoneal: KPN.

Pendiente: Susceptibilidad.

28/09: Amilasa Liq biliar 425

26/09: Amilasa Liq biliar 23883

25/09: CC Biliar: KPN MS. S: Amik, Sulbactam, Cefazolina, Cefotaximo, Cipro, Genta, TMX.

ANTIBIÓTICOS:

·Imipenem 500mg c/6hr EV (02/10)Empírico

·Vancomicina 1gr c/12hr EV (02/10) Carga de 2 gramos Empírico

Anidulafungina 100mg c/día EV (02/10) Carga de 200gr Empírico.

Control 01/10:

Lact 262 (289, 228) Ck total 1407 Mb 14.5 Troponina I 940 (143) Glucos 135

Ph 7.08 Pco2 43.9 PO2 86 HCO3 12.7 Be -17.2

Ggt 48 tgo 1504 (1153) Tgp 545 (520)

Creat 2.69 (2.27, 1.6) Bun 17.5 (15.6)

Ca 9.8 Na 161 (163, 153) K 3.79 (3.55) Cl 111

PCR 183 (172, 114) Wbc 32.23 (26.6)

Hb 11.6 (12, 7.4) Hto 35.9 (22.7) Plaq 159 (126)

Pt 25/35 inr 2.46 ttpk 30

Evoluciona en malas condiciones generales, con shock séptico severo refractario, se somete a hemofiltración de alto volumen sin respuesta, evolucionando con falla orgánica múltiple (coagulación, circulación, ventilatorio, renal)

Se determina inicio de cuidados de fin de vida

Fallece acompañada de familiares a las 9.45 del 03.10

DIAGNÓSTICOS:

1. SHOCK SÉPTICO MIXTO FOCO ABDOMINAL E HIPOVOLÉMICO REFRACTARIO (01/10)

a. FOM en manejo

Hemodinámica 3 DVA

Renal oligoanúrica

Hepática por hepatitis isquémica

Coagulopatía

b. HFVVC sin respuesta

2. RE-LAPAROTOMÍA SUBCOSTAL BILATERAL POR SHOCK HEMORRÁGICO (30/09)

a. Hematoma organizado en relación a la yeyunoanastomosis drenado

b. Anastomosis desmantelada por lo que se decide completar Pancreatectomía + esplenectomía.

Dren J. Prat cara anterior de la anastomosis biliodigestiva, Dren Tubular a logia esplenica.

f. Transfundida 6ui GRE + 6ui PFC + 1 pool Crioprecipitado.

3. ADENOCARCINOMA DE AMPOLLA OPERADO - CX DE WHIPPLE (25/09)

a. Pancreatoduodenectomía con preservación de píloro/Reconstrucción con asa de Child / Pancreatoyeyunoanastomosis / Hepaticoyeyuno, anastomosis / Píloroyeyuno anastomosis + Colectomía (25/09)

Dren J. Prat cara posterior y anterior de la pancreatoyeyuno y anastomosis biliodigestiva

Diagnóstico de Egreso

Sepsis -

Condición de Egreso

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallece acompañada de familiares

Plan Post Alta

Indicaciones

Fecha Epicrisis : 10/10/2024 17:23

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:33

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 10-10-2024 17:23:11

Página 3 de 3

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Constanza Godoy Santin

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 10/10/2024 17:23

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:33

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar